DATO DE ATENCIÓN URGENCIA (DAU)

ESTABLECIMIENTO :	HOSPITAL SAN CARLOS	N°DAU :	4475545
CALIDAD :	Original	FECHA :	19/03/2026 08:06
AREA :	U.E. Adulto	BOX :	4
HC :	2002209620	CTA. CTE. :	0

DATOS CONSULTANTE:

Nombre : ZOILA DEL CARMEN QUEZADA JAQUE **RUN** : 6.174.494-0 **CP** : 347084
Previsión : FONASA B **F.Nac** : 29/06/1946 **Género** : Femenino **Edad** : 79 Años 8 Meses 20 Días
Dirección : QUINQUEHUA S/N // **Comuna** : SAN CARLOS **Teléfono** : 95116493

DATOS INGRESO:

Procedencia : 1_EXTERIOR **Mot. Consulta** : MORBILIDAD COMUN
Lug. Ocurrencia : NO_ESPECIFICADO **Med. Llegada** : A PIE O CAMINANDO

SELECTOR DEMANDA: 1° llamado: 19/03/2026 08:08:40;

Profesional : Cynthia Ortega Molina **Hra. Llamada** : 19/03/2026 08:08 **Hora Atención** : 19/03/2026 08:13
T° Axilar : 0 **T° Rectal** : **Presión** : **Pulso** : 110 **Frec. Resp.** : 0
Saturometría : 93 **HGT** : **Peso** : **Glasgow** : **Clasificación** : C3
Motivo de consulta: : TRAIDA POR FAMILIAR POR DECAIMIENTO, NAUSEAS, DOLOR EN EPIGASTRIO
SAT93 FC107 T38.6 PA157/89
ALERGIA NO
AM HTA, CARDIOPATIA, EPOC
QUEDA EN BOX POR ESTAR FEBRIL

CONTROL SIGNOS VITALES:

Fecha	Pulso	Presión	T° Axilar	T° Rectal	FR	Sat.	HGT	Profesional
19/03/2026 09:47	105	128/67	38.4			91		Ruth Sepulveda Poblete
19/03/2026 09:49							122	Ruth Sepulveda Poblete
19/03/2026 12:32	76	114/52	37.1			93		STEPHANIE CAROLINA MARABOLÍ ALMARZA

ACCIDENTE, ALCOHOLEMIA Y/O TOXICOLOGIA:

INFORME LESIONES : NO **INFORME ALCOHOLEMIA:** : NO

ANAMNESIS: 1° llamado a box: 19/03/2026 09:00:26;

Fecha	Anamnesis	Profesional
19/03/2026 09:06	am: icc, hta, acv, epoc fcos: lst, hct, aas, dabigatran, ipratropio mc: acude por cuadro febril desde la mañana, al ingreso febril, taquicardica, sat dentro de rango sin apremio ventilatorio, presenta tos productiva mayor que la habitual, fue evaluada ayer por medico quien diagnosticaz neumonia he indica amoxicilina. sumado a esto presenta intolerancia oral y leve dolor en abdomen superior. se recepciona laboratorio el cual evidencia parametros elevados, rxtx con neumonia multifocal + atelectasia a derecha. dados antecedentes, edad y cuadro actual, se decide postular a HODOM para continuar con tto atb ev, reev y kinesioterapia segun categorizacion.	DIEGO ANDRÉS VÁSQUEZ MANOSALVA

EXAMEN FÍSICO :

Fecha	Examen Físico	Profesional
19/03/2026 09:06	regulares condiciones generales, febril, taquicardica, hidratacion limite. mp (+) con presencia de roncus grueso y crepitos a derecha, a izq con roncus, sin sibilancias rr2tss abdi sin focalidad neurologica, glasgow 15.	DIEGO ANDRÉS VÁSQUEZ MANOSALVA

DIAGNÓSTICOS: **Condición de ingreso:** Conciente

Fecha	Hipótesis diagnóstica	Profesional
19/03/2026 09:10	J18.0 BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	DIEGO ANDRÉS VÁSQUEZ MANOSALVA

PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y/O TERAPÉUTICOS (TRATAMIENTO EN BOX):

Fecha	Procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos	Profesional	Estado	Responsable
19/03/2026 09:10	rl 250 cc + metamizol 1 gr ev + ketorolaco 30 mg ev a pasar en 30 min	DIEGO ANDRÉS VÁSQUEZ MANOSALVA	Cancelado el 19/03/2026 10:22	Camila Andrea Navarrete Riquelme Obs:POR MEDICO
19/03/2026 09:10	rxtx	DIEGO ANDRÉS VÁSQUEZ MANOSALVA	Ejecutado el 19/03/2026 10:22	Camila Andrea Navarrete Riquelme Obs:TOMADO
19/03/2026 09:10	laboratorio general	DIEGO ANDRÉS VÁSQUEZ MANOSALVA	Ejecutado el 19/03/2026 10:22	Camila Andrea Navarrete Riquelme
19/03/2026 09:12	o2 segun necesidad para sat 88-92% (mmv fio224%)	DIEGO ANDRÉS VÁSQUEZ MANOSALVA	Ejecutado el 19/03/2026 10:23	Camila Andrea Navarrete Riquelme Obs:SAT91% AMB
19/03/2026 09:37	control de sv	DIEGO ANDRÉS VÁSQUEZ MANOSALVA	Ejecutado el 19/03/2026 09:47	Ruth Sepulveda Poblete
19/03/2026 10:13	sf 250 cc + 1 gr metamizol + 30 mg ketorolaco ev	DIEGO ANDRÉS VÁSQUEZ MANOSALVA	Ejecutado el 19/03/2026 10:22	Camila Andrea Navarrete Riquelme
19/03/2026 12:11	ceftriaxona 2 gr ev	DIEGO ANDRÉS VÁSQUEZ MANOSALVA	Ejecutado el 19/03/2026 13:07	Camila Andrea Navarrete Riquelme
19/03/2026 12:11	azitromicina 500 mg vo	DIEGO ANDRÉS VÁSQUEZ MANOSALVA	Ejecutado el 19/03/2026 12:32	Ruth Sepulveda Poblete

EXAMENES:

Fecha	Examen	Profesional
19/03/2026 09:12	Recuento Globular ; Pcr ; Electrolitos Plasmaticos ; Programa Hepatico ; BUN Nitrogeno Ureico ; Creatinina ; Lactato ; Perfil Gasometria Venosa ;	DIEGO ANDRÉS VÁSQUEZ MANOSALVA
19/03/2026 09:12	RX TÓRAX FRONTAL Y LATERAL	Diego Andrés Vásquez Manosalva

INDICACIONES ALTA:

Fecha	Indicación	Profesional
19/03/2026 13:45	HOSPITALIZAR EM HODOM REPOSO RELATIVO ASISTIDO REGIMEN HIPOSODICO HIPOGLUCIDO CEFTRIAXONA 2 GR EV DIA CLARITROMICINA 500 MG CADA 12 HRS VO B.IPRATROPIO 4 PUFF CADA 6 HRS X Aec paracetamol 1 gr vo cada 8 hrs knt respiratorio	DIEGO ANDRÉS VÁSQUEZ MANOSALVA

o2 segun necesidad para sat 88-92%

mantener otros farmacos de uso cronico

RECETAS:

Fecha	Prescripción	Profesional
19/03/2026 14:24	CEFTRIAXONA 2 GR EV DIA CLARITROMICINA 500 MG CADA 12 HRS VO B.IPRATROPIO 4 PUFF CADA 6 HRS X Aec paracetamol 1 gr vo cada 8 hrs	DIEGO ANDRÉS VÁSQUEZ MANOSALVA
19/03/2026 12:15	azitromicina 500 mg comprimido	DIEGO ANDRÉS VÁSQUEZ MANOSALVA

OBSERVACIONES:

Fecha	Indicación	Profesional
19/03/2026 10:23	SE INSTALA VVP NUM 18 BD, PRIMER INTENTO	Camila Andrea Navarrete Riquelme
19/03/2026 13:10	Mujer 79a, ICC, EPOC/bronquiectasias, TEP reciente (feb 2026) en TACO c/ dabigatrán, desnutrición severa. Múltiples consultas en servicios de urgencia, 3 hospitalizaciones en 4 meses. Hoy: Cuadro clínico compatible con neumonia, fiebre 38.6, FC 107, sat 93% aa. Labs: leucocitosis 17.5 c/ neutrofilia, PCR 32.8, BUN 24, ELP normales (Na 135), Crea 0.70, ClCr 80.5, Hb 11.1, INR 1.09, lactato 0.8, GSV c/ alcalosis metabólica crónica sin hiperlactatemia. Perfil hepático normal. RxTx s/ hallazgos nuevos (cambios crónicos conocidos). . Se acepta ingreso a HODOM: crónica reagudizada, diagnóstico establecido, red de apoyo presente, domicilio en radio cobertura. . Plan: ceftriaxona ev c/24h, Claritromicina 500 mg c12h vo, KNT respiratoria, control labs 48h, mantener dabigatrán y tratamiento crónico.	Felix Antonio Sanhueza Luna

GES : No **PERTINENCIA** : Si **DESTINO** : Hospital APS

ADVERTENCIA
ESTE ES UN DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO Y SÓLO UNA PRIMERA ATENCIÓN. DEBE CONSULTAR A SU CENTRO DE SALUD O MÉDICO TRATANTE DENTRO DE LAS 12-24 HORAS SIGUIENTES. SI SUS SÍNTOMAS EMPEORAN, CONSULTE NUEVAMENTE A LA BREVEDAD. ES SU RESPONSABILIDAD SEGUIR ESTAS INDICACIONES.

LLAME A SALUD RESPONDE
600·360·7777
PROFESIONALES DE LA SALUD ATENDIENDO SUS DUDAS LAS 24 HORAS, LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA

www.hospitalsancarlos.cl
Fono: +56 42 2586130

ORIGINAL: PACIENTE
24810521015

DIEGO ANDRÉS VÁSQUEZ MANOSALVA
19.816.009-1